

Dr. Cassio

JOSE ANTERO DE PAIVA GRILLO	
SINTOMAS / QUEIXAS	HAS / DM / Desvio Septo Nasal (E)
MEDICAMENTOS	Amezonana / Cardiol / Amolipino / glicose
HORA QUE DORME :	22
HORA QUE ACORDA :	F / Latência 34'
BANHEIRO	3X à 4X
TIPO DE RESPIRAÇÃO	Nasal (usa narisidrum) faz ruído 40' 25 despertares
PRÁTICA EXERCÍCIO	Musculação (há 10 d.)
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ :	SIMALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: —
IDADE: 76a	PESO: 94 Kg IAH: 18.9 MALLAMPATI: 3 SPO2: 71%
23/02	Adaptação do CPAP aut.
23	Donne! q ar ligado 23°
02/03	P = 5.1 - 5.6 cmH ₂ O
23	IAH = 0.7 elev M. de uso: 9h37' Relato aquecimento do Tº
09/03	P = 5.6 média
23	IAH = 1 M. de uso: 9h31' Bem adaptado, relata que retira másc. s/ perceber
16/03	P = 5.6 média.
23	IAH = 0.6 elev M. de uso: 9h Vazão = 4.2 l/min.
27/03	P = 5.3 cmH ₂ O
23	IAH = 1.2 elev M. de uso: Vazão: 0.0 l/min. Bem adaptado, s/ queixas
26/04	P = 5.3 cm
23	IAH = 0.7 elev M. de uso: 8h50'
26/06	P = 5.2 cmH ₂ O. P.O2 = 6.25 cmH ₂ O
2023	IAH = 0.8 elev M. de uso: 7h45' min. Vazão = 4 l/min
21/09	P = 5.2 cmH ₂ O
23	IAH = 0.8 elev M. de uso: 7h30'
09/10/23	coloca CPAP usual e envia o outro CPAP p manutenção

lua

lua

lua

lua

lua

lua

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOSE ANTERO DE PAIVA GRILO			
Sexo: M	Idade: 76 anos	Peso: 92 Kg	Altura: 1,80 m
IMC: 28,4	Data do Exame: 21/01/2023	Exame: 12111_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:18:10 horas e encerrado às 05:02:57 horas, com latência para o sono de 34 minutos e latência para o sono REM de 328 minutos. O tempo total de sono foi de 321,5 minutos, com eficiência do sono de 79,4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,1%	Até 5%
Estágio 2	75,3%	45 - 55%
Estágio 3	17,0%	> 15%
Sono REM	6,7%	20 - 25%
Eficiência do sono	79,4%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 49,5 minutos ocorreram **135 despertares** (índice de **25,2 /hora**).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 71 bpm , a maior de 84 bpm e a menor de 65 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 101 eventos respiratórios, sendo 0 central, 101 obstrutivos e 0 misto. Sendo 25 apnéias, 76 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 18,9/hora**, sendo 4,7 apnéia/hora e 14,2 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 23,5 e a duração máxima de 33,0.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 55,8/hora, sendo 19,5 apnéia/hora e 36,3 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **93%**, sendo a **saturação média de 89%**, a **maior de 94%** e a **mínima de 71%**, permanecendo 226,2 minutos (55,8%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,3 minutos (0,1%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 102 dessaturações. Índice de dessaturações: 18,8/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 56,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 16,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomon de Dominis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842